

Дата: 28.11.2025

Полис ОМС: 2988299720000033

Медицинское учреждение : Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии - Клиника доктора Рошалья Департамента здравоохранения города Москвы

Специализация: Врач-рентгенолог

ФИО: БОЖКО О В

Магнитно-резонансная томография коленного сустава

Информация об исследовании	Предварительный диагноз: не указано Цель исследования: не указано Обоснование: не указано Дата исследования: 28 ноября 2025, 13:51 Номер исследования: 5625105970
Тип чтения	Первое чтение.
Место проведения расшифровки исследования	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии - Клиника доктора Рошалья" Департамента здравоохранения города Москвы.

Описание	Дата проведения исследования: 28.11.2025 11:34 Описание результатов: Состояние после артроскопии левого коленного сустава, удаления свободных и фиксированных к/хр фрагментов патологического очага надколенника с артротомией, иссечения патологической хрящевой ткани, микрофрактурирования и хондропластики JointRep, пластики МПФЛ аутосухожилием m.semitendinosus, медиализации и дистализации бугристости большеберцовой кости, парциального латерального релиза от 24.01.2025 г. На сериях контрольных МР томограмм левого коленного сустава, полученных в 3-х плоскостях, в положении сканирования взаимоотношения в коленном суставе не нарушены, суставные поверхности в целом конгруэнтны. Зоны роста практически закрыты. В дистальном отделе бедренной кости определяется костный канал с фиксирующим винтом без перифокального отека. Зоны умеренного трабекулярного отека определяются по задней поверхности дистального эпифиза в межмышечкловй области, в межмышечковом возвышении большеберцовой кости. На краю зоны сканирования сохраняются артефакты неоднородности магнитного поля от фиксирующих элементов бугристости болшеберцовой кости. Сохраняется умеренная деформация кортикального слоя передне-боковой поверхности латерального мыщелка бедренной кости. Гиалиновый хрящ остальных отделов суставной поверхности мыщелков бедренной кости и большеберцовой костей значимо не изменен. Форма и положение менисков значимо не изменены, МР сигнал от них не изменен. Задняя и передняя крестообразные, латеральная коллатеральная связки прослеживаются на всем протяжении, стриарность сохранена. Медиальная коллатеральная, латеральная пателло-фemorальная связки и подвздошно-большеберцовый тракт неоднородны, утолщены, с прерыванием части волокон (операционный доступ).Трансплантат медиальной пателло-фemorальной связки прослеживается удовлетворительно, утолщен, гиперинтенсивен в местах крепления. Сухожилие четырехглавой мышцы бедра и собственная связка надколенника так же отчетны, траектория их сохранена. В положении сканирования индекс Insall-Salvati около 1,7 (ранее 1,4). Индекс TT-PCL около 20 мм (ранее около 24,0 мм). Надколенник по форме Wiberg III, обычных размеров, не смещен. Визуализируется два костных канала с фиксированными в них винтами. Отмечается трабекулярный отек надколенника, более выраженный в медиальных отделах. Суставная поверхность надколенника имеет неровный контур, хрящ неоднороден, в области гребня выявляются субхондральные кисты диаметром около 3 мм. Сохраняется деформация нижне-медиального края надколенника. Отмечается отек жирового тела Гоффа в верхнемедиальном отделе. Синовиальная оболочка утолщена, отечна. В полости сустава незначительное количество выпота. Параартикулярные мягкие ткани неравномерно отечны. Заключение: МРТ картина состояния после ранее перенесенного вывиха надколенника левого коленного сустава и последующего хирургического лечения (подробно в примечании): признаки лигаментоза трансплантата медиальной пателло-фemorальной связки, положение его удовлетворительное; импрессионная деформация передне-наружных отделов латерального мыщелка бедренной кости; положение бугристости большеберцовой кости удовлетворительное; диффузный отек надколенника; хондромалиция гребня и медиальный фасетки надколенника; послеоперационные изменения латеральной фасетки надколенника; рубцовые изменения медиального ретинакулюма и медиальной пателло-фemorальной связки; умеренный выпот в полости сустава; признаки синовита и отека супрапателлярного жирового тела; отек волокон подколенной мышцы. При сравнении с данными от 25.07.2025 отмечается лигаментизация аутоотрансплантата медиального удерживателя надколенника, формирование субхондральных кист в области гребня надколенника, уменьшение зоны трабекулярного отека надколенника. Идентификатор протокола (diagnostic): 2.25.50549092042579519746141065921458657759 Тип чтения: Первое чтение Наименование места проведения расшифровки: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии - Клиника доктора Рошалья" Департамента здравоохранения города Москвы Идентификатор места проведения расшифровки: 100000090548
----------	--

Оборудование	Название устройства: Philips Ingenia Ambition S 1.5T (ПО). Вид: ING_NDHT. Инвентарный номер: 620725. Серийный номер: 48308. Модель: Philips Ingenia Ambition S 1.5T.
--------------	--